

PARLER À L'ÉQUIPE SOIGNANTE

Quand, comment, à qui — et comment être vraiment entendu.

Guide B — Série pratique EHPAD · Culture du soin

Sommaire

1. Pourquoi la communication coince

Comprendre les obstacles pour mieux les contourner.

2. Quand parler — et quand ne pas parler

Les bons moments, les mauvais moments, les urgences.

3. Comment formuler ce que vous avez à dire

Les mots qui ouvrent le dialogue. Ceux qui le ferment.

4. Mettre par écrit — quand et comment

Écrire sans escalader. Laisser une trace sans créer un conflit.

5. Les phrases toutes faites — à utiliser ou adapter

Des modèles concrets pour les situations les plus fréquentes.

6. Quand ça ne passe pas — que faire

Escalader sans exploser. Insister sans braquer.

Introduction

Communiquer avec une équipe soignante en EHPAD, ce n'est pas intuitif. Ce n'est pas comme parler à un médecin de ville, ni comme gérer une relation de service ordinaire. C'est un écosystème particulier, avec ses codes, ses contraintes, ses points de tension.

Beaucoup de familles se retrouvent dans l'un de ces deux extrêmes : soit elles n'osent pas parler, de peur de déranger ou d'être mal perçues. Soit elles parlent dans la tension, et le dialogue se ferme avant même d'avoir commencé. Entre les deux, il y a un chemin. Ce guide est là pour le baliser.

Ce que j'observe sur le terrain

Les familles qui obtiennent le plus des équipes ne sont pas celles qui réclament le plus fort. Ce sont celles qui savent quoi demander, à qui, et comment. Elles créent un lien. Elles respectent le rythme. Et les soignants, en retour, vont un peu plus loin pour elles — pas par obligation, mais parce qu'une relation s'est installée.

Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la stratégie.

1. Pourquoi la communication coince

Avant de chercher à mieux communiquer, il faut comprendre pourquoi c'est difficile. Des deux côtés.

Du côté des soignants

- Ils sont sous pression permanente. Entre deux soins, le temps pour parler aux familles est limité — et souvent non prévu dans les plannings.
- Ils ont peur du jugement. Une question de famille peut être perçue comme une mise en cause. Ils se ferment par réflexe de protection.
- Ils ne savent pas toujours ce qu'ils peuvent dire. Les questions médicales relèvent du médecin. Les décisions institutionnelles relèvent de la direction. Ils naviguent dans des périmètres flous.
- Les transmissions sont imparfaites. Ce que vous avez dit le matin n'est pas forcément connu de l'équipe du soir. Ce n'est pas de la négligence — c'est une réalité organisationnelle.

Du côté des familles

- Elles arrivent chargées émotionnellement. L'inquiétude, la culpabilité, l'impuissance — tout cela colore ce qu'elles disent et comment elles le disent.
- Elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles parlent à la première personne disponible, qui n'est pas toujours la bonne.
- Elles interprètent le silence comme du désintérêt. Or le silence est souvent juste du débordement.
- Elles oscillent entre trop de retenue et trop d'intensité. Les deux ferment le dialogue.

La communication ne coince pas parce que les gens sont mauvais. Elle coince parce que le système est tendu et que personne n'a appris à naviguer dans cet espace-là.

2. Quand parler — et quand ne pas parler

Le timing est presque aussi important que le contenu. Un bon message au mauvais moment ne passe pas.

Les moments à éviter

- **Les changes et les toilettes du matin (7h–10h).** C'est le moment de pointe. L'équipe est en plein soin, chronométrée. Une conversation à ce moment peut être perçue comme une intrusion.
- **La distribution des repas.** Même logique : moment chargé, attention partagée entre de nombreux résidents.
- **La passation de consignes entre équipes.** En général vers 14h et 21h selon les établissements. L'équipe est en réunion interne — pas disponible.
- **Dans le couloir, à la volée.** Pour tout sujet important, ne comptez pas sur une conversation improvisée. L'information ne sera pas transmise, le soignant sera distrait. Prenez rendez-vous.

Les bons moments

- **En milieu de matinée (10h30–12h).** Les soins du matin sont généralement terminés. L'équipe dispose d'un peu plus de disponibilité.
- **En début d'après-midi (14h30–16h).** Hors passation de consignes, c'est souvent un moment plus calme.
- **Sur rendez-vous fixé à l'avance.** Pour tout sujet qui nécessite plus de cinq minutes. Appelez le matin pour convenir d'un créneau avec la cadre. C'est la règle d'or.

Les urgences — cas à part

Si vous découvrez quelque chose d'inquiétant à votre arrivée — une blessure, un état de détresse, une situation anormale — ne cherchez pas le bon moment. Signalez immédiatement à l'infirmière de service. C'est son rôle de traiter les urgences, quelle que soit l'heure.

Pour les sujets importants : prenez toujours rendez-vous. Ne comptez jamais sur le couloir.

3. Comment formuler ce que vous avez à dire

La forme change tout. Pas parce que le fond n'a pas d'importance — il en a énormément. Mais parce que la forme détermine si votre interlocuteur va être en mode "écoute" ou en mode "défense".

La structure qui fonctionne

Quelle que soit la situation, cette structure en trois temps est efficace :

- **Ce que j'observe.** Des faits concrets, sans interprétation. "J'ai remarqué que ma mère a une rougeur sur le talon depuis mardi."
- **Ce que je ressens ou ce qui m'inquiète.** Sans accusation. "Ça m'inquiète parce qu'elle a tendance à faire des escarres rapidement."
- **Ce que je demande.** Précis, concret, réaliste. "Est-ce que quelqu'un peut regarder ça aujourd'hui et me dire ce qui est prévu ?"

Cette structure évite deux pièges fréquents : le flou ("ça ne va pas" sans préciser quoi) et l'accusation implicite ("personne ne s'occupe d'elle").

Les mots qui ouvrent le dialogue

- "Je me demandais si..."
- "Est-ce que vous pouvez m'expliquer..."
- "J'ai remarqué quelque chose qui m'inquiète, est-ce que je peux en parler avec vous ?"
- "Je voudrais comprendre ce qui s'est passé..."
- "Je sais que vous êtes chargé, je veux juste vous donner une information importante sur mon père."

Les mots qui ferment le dialogue

- "Personne ne s'en occupe." — Accusation globale. Défense immédiate.
- "Vous devriez..." — Met l'équipe en position d'être jugée.
- "Ce n'est pas normal." — Peut être vrai, mais dit comme ça, ça coupe le dialogue avant de l'ouvrir.
- "Je vais porter plainte si..." — À garder pour les situations vraiment graves. Utilisé trop tôt, cela bloque toute relation future.
- "À la maison, on faisait autrement." — L'équipe l'entend comme une critique de leur travail. Même si c'est légitime, reformulez.

Donner de l'information sur votre proche

Vous connaissez votre proche mieux que quiconque. Ces informations sont précieuses pour l'équipe. Mais elles doivent être transmises sous forme d'informations — pas de directives.

Moins efficace : “Ma mère doit absolument avoir son café sucré le matin, c’est fondamental.”

Plus efficace : “Ma mère a toujours pris son café sucré le matin, c’est un repère important pour elle depuis toujours. Est-ce que c’est possible de noter ça dans ses habitudes ?”

Vous n’êtes pas là pour avoir raison. Vous êtes là pour être entendu.

4. Mettre par écrit — quand et comment

Écrire, c'est laisser une trace. Cela peut être un outil puissant. Cela peut aussi être perçu comme une escalade si c'est mal dosé.

Quand écrire

- Pour transmettre des informations importantes sur votre proche (habitudes, peurs, préférences) — un petit mot ou un mail garantit que ça reste.
- Pour confirmer une demande faite à l'oral — “Suite à notre conversation de ce matin, je confirme ma demande de rendez-vous avec...”
- Quand une demande orale est restée sans réponse après quelques jours.
- Pour signaler une situation grave que vous voulez voir traitée officiellement.

Comment écrire — les règles

- **Restez factuel.** Ce que vous avez observé, la date, l'heure. Pas d'interprétation, pas de jugement.
- **Soyez concis.** Un mail long est un mail qui ne sera pas lu attentivement. Trois paragraphes maximum.
- **Terminez par une demande claire.** “Je souhaite un retour avant vendredi.” ou “Pouvez-vous me confirmer que ce point a été transmis ?”
- **Gardez une copie.** Toujours. Avec la date d'envoi.
- **Ton respectueux, même si vous êtes en colère.** Un mail agressif génère une réponse défensive. Un mail calme et factuel ouvre une porte.

À qui envoyer

Pour les questions de soins : la cadre de santé. Pour les questions administratives ou si la cadre n'a pas répondu : la direction. Pour les situations graves : les deux, en copie l'une de l'autre. Cela montre que vous êtes organisé et sérieux — pas que vous montez les uns contre les autres.

Un écrit bien rédigé dit : je suis sérieux, je suis organisé, et je garde une trace. C'est suffisant pour que les choses bougent.

5. Les phrases toutes faites — à utiliser ou adapter

Voici des formules testées pour les situations les plus fréquentes. Adaptez-les à votre ton, votre situation, votre proche.

Pour demander un rendez-vous

“Bonjour, je suis [prénom], la fille de M. [nom] au [numéro de chambre]. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec la cadre de santé pour faire le point sur la situation de mon père. Quel est le meilleur moment cette semaine ?”

Pour signaler un changement inquiétant

“J’ai remarqué que ma mère semble beaucoup plus fatiguée que d’habitude depuis ma dernière visite. Elle mange très peu et semblait confuse tout à l’heure. C’est inhabituel pour elle. Est-ce que quelqu’un peut y jeter un oeil et me dire ce qu’il en pense ?”

Pour demander des explications sur un traitement

“J’ai remarqué que le médicament X n’est plus dans la liste de mon père. Est-ce que vous savez si c’est volontaire, et si oui, pour quelle raison ? Je voudrais comprendre avant d’en parler avec le médecin.”

Pour transmettre une information sur les habitudes

“Je voulais vous dire quelque chose sur ma mère qui peut aider l’équipe. Elle a toujours été très attachée à sa coiffure — être bien coiffée le matin, c’est important pour elle, ça touche à son identité. Si c’est possible de noter ça quelque part, ça ferait une vraie différence.”

Pour relancer sans être agressif

“Je vous avais contacté mardi dernier au sujet de [sujet]. Je n’ai pas eu de retour depuis. Je comprends que vous êtes très chargés, mais ce point est important pour moi. Pouvez-vous me dire quand je peux avoir une réponse ?”

Pour exprimer une insatisfaction sans escalader

“Je veux vous dire quelque chose qui me trouble, et je préfère vous le dire directement plutôt que de laisser ça s’installer. [Description factuelle]. Je ne cherche pas à accuser qui que ce soit — je veux juste comprendre et voir ce qu’on peut faire ensemble.”

Une demande claire et respectueuse obtient dix fois plus de résultats qu’une plainte diffuse.

6. Quand ça ne passe pas — que faire

Vous avez bien fait les choses. Vous avez été clair, respectueux, vous avez pris rendez-vous, vous avez écrit. Et ça ne bouge pas. Voici la marche à suivre.

Étape 1 — Remonter d'un niveau

Si la cadre de santé n'a pas répondu ou n'a pas donné suite — demandez un rendez-vous avec la direction. Expliquez que vous avez déjà contacté la cadre sans résultat. Ne sautez pas cette étape — elle montre que vous avez suivi la voie normale avant d'escalader.

Étape 2 — Mettre par écrit formellement

Un courrier ou mail à la direction, avec copie à la cadre, résumant les faits, les démarches effectuées et la demande précise. Mentionnez les dates de vos contacts précédents. Un écrit formel signale que vous êtes sérieux — sans encore passer aux instances extérieures.

Étape 3 — Le Conseil de la Vie Sociale

Si votre problème concerne le fonctionnement général de l'établissement, vous pouvez le soumettre au CVS. C'est l'instance officielle où les familles ont une voix. Voyez le Guide C pour comprendre comment fonctionne le CVS.

Étape 4 — Les voies extérieures

Si la situation est grave et ne se règle pas en interne — il existe des recours extérieurs : le Médiateur de la République, l'Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil Départemental. Ces recours sont détaillés dans le Guide F — “Quand ça coince”.

Escalader, ça se fait pas à pas. Chaque étape que vous avez franchie renforce la suivante.

Vous avez le droit d’être entendu.

Et maintenant vous savez comment y arriver.

—

Ce guide fait partie de la série pratique EHPAD. Les autres guides de la série :

- **Guide A — Qui est qui :** rôles, responsabilités, bons interlocuteurs.
- **Guide C — Les réunions :** CVS, synthèses, projet de vie.
- **Guide D — Vos droits :** accès dossier, réclamation, loi.
- **Guide E — Le quotidien :** soins, repas, nuit, sorties, argent.
- **Guide F — Quand ça coince :** conflits, signalement, recours.
- **Guide G — Le changement d’EHPAD :** quand et comment partir ailleurs.

—

Et si vous voulez préparer un entretien difficile, rédiger un courrier ou simplement ne plus être seul face à une situation complexe — je suis là.

[Votre lien de contact / site]

— *Culture du soin*